

Il vostro familiare autistico in cura residenziale / ad alto supporto

Per famiglia e familiari — sostenere una persona autistica in **assistenza residenziale / ad alto supporto** (qualsiasi età).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione del vostro familiare si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. Gli ambienti di cura sono spesso i **più difficili in assoluto**: ostili sensorialmente, rompono le routine, pieni di tocco e richieste imprevedibili. Molti in cura ad alto supporto comunicano senza parole e possono non registrare o riferire dolore finché non è grave. Il vostro ruolo di famiglia è potente: siete la loro **memoria, il loro avvocato e la loro continuità** — proteggendo le loro routine, i loro oggetti e i loro interessi, guardandovi dai bisogni non soddisfatti e insistendo che siano trattati come una persona con agency, mai un „comportamento” da gestire.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
„Comportamento problematico”, autolesionismo, rifiuto	Nella stragrande maggioranza comunicazione di un bisogno non soddisfatto — dolore, paura, sovraccarico, routine persa
Angoscia dopo un cambio di personale, stanza o routine	La prevedibilità e le cose sono ancore di identità e sicurezza
Non riferisce dolore; collasso improvviso o presentazione tardiva	Differenze di interocezione — i segnali interni possono non registrarsi finché non sono gravi
Ritirato, sedato, o „tranquillo”	Forse burnout, depressione o sovra-farmacoterapia — „quiete” non è sempre „bene”
Nessun linguaggio affidabile; si affida a CAA o a un accompagnatore	Comunicazione atipica ≠ mancanza di capacità o comprensione

Provate questo

- **Siate la loro continuità** — condividete un profilo di una pagina dei loro interessi, routine, bisogni sensoriali, segnali precoci e cosa li regola; mantenetelo aggiornato.
- **Insistete che il dolore e le cause fisiche siano esclusi per primi** per ogni nuova angoscia — stipsi, dolore dentale, infezione, attrezzatura mal adattata sono colpevoli comuni e nascosti.
- **Protegete routine, oggetti e interessi** — sono benessere, non disordine; chiedete che siano preservati attraverso i cambi di personale.
- **Spingete per la presa di decisione supportata** e un piano comunicativo/sensoriale individualizzato; chiedete formazione del personale sull'autismo.
- **Visitatelo e connivetevi attraverso il suo interesse**, alle sue condizioni — siete un salvagente per identità e affetto.

Evitate questo

- Accettare etichette „comportamentali” prima che dolore e sovraccarico siano esclusi.
- Lasciare che contenimento o sedazione diventino risposte di routine a meltdown/shutdown.
- Rimuovere cose o routine „per il loro bene”, o dare per scontata l’incapacità da una comunicazione atipica.

Quando serve altro supporto

Trattate l’**angoscia nuova o crescente** come un segnale d’allarme medico finché non sono esclusi dolore, infezione, stipsi, problemi dentali e cause sensoriali/ambientali. Coinvolgete **équipe specialistiche autismo / disabilità intellettiva** e logopedia (CAA). Richiedete un **„passaporto ospedaliero / sanitario”** per qualsiasi ricovero, e un piano scritto e calmo di meltdown/shutdown che priorizzi la sicurezza sul contenimento.

Nota di genere

Le donne ad alto supporto sono particolarmente sotto-identificate e mal servite, e la loro angoscia è ancora più spesso letta male. Applicate lo stesso rigore nell’escludere dolore e sovraccarico a prescindere dalla presentazione o dal metodo di comunicazione.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parte 5, case di cura e ospedali) e la sintesi sul **Monotropismo**, con la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parti 3.5 e 4). Usa il linguaggio con l’identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico.** Adattatela al/dalla singolo/a; voi lo/la conoscete meglio di chiunque altro.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interocezione/dolore); Autism Society (2025, meltdown/shutdown); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.